

La cistitis intersticial, también llamada síndrome de dolor vesical (CI/SDV), es una afección de larga duración con **dolor, presión o molestia en la vejiga o la pelvis** junto con una necesidad frecuente o urgente de orinar — **sin** que una infección la cause. La molestia suele aumentar a medida que la vejiga se llena y disminuye después de orinar. Se puede controlar bien, aunque no hay una cura de un solo paso.

Acerca de esta afección

La CI/SDV no es una infección y no es contagiosa. Los síntomas varían de una persona a otra y tienden a presentarse en **brotes** (épocas peores) y períodos más tranquilos. Características comunes:

- Dolor, presión o molestia en la vejiga o la pelvis
- Necesidad frecuente y/o urgente de orinar, de día y de noche
- Molestia que **empeora a medida que la vejiga se llena** y mejora después de orinar
- Brotes que pueden aparecer después de ciertos alimentos, el estrés o su ciclo menstrual

Qué la causa

No se conoce la causa exacta. Es probable que intervenga una combinación de un revestimiento de la vejiga sensible o irritado, nervios demasiado sensibles y (a menudo) un **suelo pélvico tenso y demasiado activo**. Como tiene varios factores, el tratamiento suele combinar varios enfoques.

APRENDA LOS TÉRMINOS

CI/SDV

Cistitis intersticial / síndrome de dolor vesical — dolor y urgencia en la vejiga, no por infección.

Brote

Una época de síntomas peores, a menudo provocada por la comida o el estrés.

Diagnóstico por exclusión

Se diagnostica después de descartar otras causas (como una infección).

Terapia del suelo pélvico

Terapia física para relajar los músculos pélvicos tensos.

Instilación vesical

Un medicamento calmante colocado dentro de la vejiga con una sonda delgada.

Lesión de Hunner

Una zona específica de la pared de la vejiga que se ve en algunas personas, tratable directamente.

Cistoscopia

Una mirada dentro de la vejiga con una cámara delgada.

¿ALGUNA VEZ DESAPARECERÁ? La CI/SDV suele ser una afección de larga duración, pero la mayoría de las personas logran un alivio real al combinar tratamientos y aprender sus desencadenantes. La meta es tener brotes menos frecuentes y más leves y una vida diaria normal — a menudo lleva algo de ensayo y error encontrar su combinación, así que tenga paciencia con el proceso.

Cómo se diagnostica

No hay una sola prueba. Su equipo hace el diagnóstico según sus síntomas después de descartar otras causas:

- Un **análisis de orina** para descartar infección o sangre
- Un historial de síntomas y un **diario de la vejiga**
- A veces una **cistoscopia** para buscar una lesión de Hunner

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 Autocuidado** — aprenda sus **desencadenantes alimentarios**, controle el estrés y el sueño, y use un entrenamiento suave de la vejiga.
- 2 Terapia física del suelo pélvico** — para relajar los músculos tensos (nota: los ejercicios de Kegel forzados pueden empeorarlo).
- 3 Medicamentos** — opciones orales y **instilaciones vesicales** calmantes.
- 4 Atención dirigida y avanzada** — tratar una lesión de Hunner, o estimulación de los nervios en casos difíciles.

Vivir con la CI/SDV

- Los desencadenantes comunes incluyen **café, té, alcohol, cítricos, tomates y comidas picantes** — pruebe a eliminarlos y luego volver a agregarlos para conocer los suyos.
- Tenga un **plan para los brotes** (descanso, calor, más agua, alimentos calmantes).
- El estrés y un suelo pélvico tenso alimentan el ciclo — el movimiento suave y la relajación ayudan.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre, escalofríos o dolor de espalda o del costado (posible infección)
- **Sangre en la orina** que es nueva
- Un brote que no puede controlar, o no puede orinar

TRES COSAS PARA RECORDAR

- 1.** La CI/SDV es dolor en la vejiga o la pelvis con urgencia que **no** es una infección — de larga duración, pero muy manejable.
- 2.** El tratamiento combina autocuidado y control de desencadenantes, terapia del suelo pélvico, medicamentos e instilaciones, y atención dirigida para hallazgos específicos.
- 3.** Aprenda sus desencadenantes de comida y estrés y mantenga un plan para los brotes. La sangre nueva en la orina, la fiebre o el dolor del costado deben revisarse.